

مقارنه بين مريضات سرطان الثدي والأصحاء في

أبعاد الصفاء الروحي وأبعاد معنى الحياه

أ.د. محمد إبراهيم الدسوقي

منى اسماعيل عبد العزيز الدروى

أستاذ علم النفس بكلية الآداب جامعة المنيا

باحثة دكتوراه بقسم علم نفس بكلية الآداب جامعة المنيا

ملخص

هدفت الدراسة إلى المقارنة للكشف عن طبيعة العلاقة الارتباطية بين متغيري الصفاء الروحي ومعنى الحياه ، ومقارنه قوة واتجاه هذه العلاقة بين مجموعتي الدراسة (المريضات والأصحاء)، وتحديد أيضا الفروق بين المجموعتين في الصفاء الروحي بأبعاده الفرعية، وأيضا تحديد الفروق بين المجموعتين في معنى الحياه وأبعاده الفرعية. وشملت العينة (٣٠) من مريضات سرطان الثدي، و(٣٠) من النساء الأصحاء، واستخدمت الدراسة مقياس الصفاء الروحي (لروبرتس واسبي، ١٩٩٣) ترجمه الباحثان، ومقياس معنى الحياه (الريجة محمد محمود هلال، ٢٠٢٣)، وكانت الأساليب الإحصائية المستخدمة في الدراسة الحالية معامل الفاكرونباخ واختبار Test المتوسط والانحراف المعياري وتحليل التباين المتعدد وحجم تأثيره، معامل ارتباط بيرسون ، اختبار فيشر اليدوي للمقارنة بين معاملات الارتباط. وكانت النتائج كالآتي: أولا :- عدم وجود فروق داله إحصائيا بين المجموعتين على الأبعاد السبعة مجتمعه عند مستوى دلالة (٠.٠٥) مع جود حجم تأثير كبير (٠.٢١٠).

ثانيا: - بالنسبة للمريضات فيشكل عام عدم وجود أي ارتباطات داله إحصائية بين الصفاء الروحي ومعنى الحياه عند مستوى دلالة (٠.٠٥)، باستثناء بعد الثقة في الصفاء الروحي الذي ارتبط ارتباط موجب داله مع الرضا والتسامي والدرجة الكلية لمعنى الحياه عند مستوى دلالة (٠.٠٥). أما الأصحاء لم تكن هناك لوجود أي ارتباطات داله سواء بين الصفاء الروحي والمعنى بشكل عام، أو حتى بين الأبعاد عند مستوى دلالة (٠.٠٥).

كما أثبتت الدراسة عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين مجموعتي المريضات والأصحاء عبر الأبعاد الثلاثة للصفاء الروحي مجتمعه عند مستوى دلالة (٠.٠٥) بمعنى إن الأبعاد الثلاثة ككل لا تختلف بشكل كبير بين المجموعتين. كما كان حجم تأثير صغيرا جدا (٠.٠٨٤).

كما كانت آخر النتائج عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين مجموعتي المريضات والأصحاء عبر الأبعاد الأربعة مجتمعه لمعنى الحياه عند مستوى دلالة (٠.٠٥) بمعنى إن الأبعاد الأربعة ككل لا تختلف بشكل كبير بين المجموعتين. مع ذلك، كشف التحليل عن حجم تأثير كبير (٠.١٥٢)، كما شفت الاختبارات الأحادية لكل بعد عن وجود فروق ذات دلالة إحصائية في بعد الهدف لصالح الأصحاء وبعد الرضا لصالح المريضات عند مستوى دلالة (٠.٠٥) صاحب هذه الفروق حجم تأثير كبير في بعد الهدف (٠.١٢٩) وحجم تأثير متوسط في بعد الرضا (٠.٠٣٧) . مما تشير هذه النتائج

إلى إن الحالة الصحية تؤثر على قدرة الفرد على إيجاد الهدف والرضا في حياته، كما أظهرت النتائج عن عدم وجود فروق داله بين المريضات والأصحاء في بعدى التسامي والمسئولية عند مستوى دلالة (.٠٠٠٥)

الكلمات المفتاحية: مقارنة، الصفاء الروحي ، معنى الحياة، سرطان الثدي ،الأصحاء

مقدمة

يندرج هذا الموضوع ضمن تطبيقات علم النفس الإكلينيكي وتهدف الدراسة الراهنة إلى المقارنة للكشف عن طبيعة العلاقة الارتباطية بين متغيري الصفاء الروحي ومعنى الحياة ، ومقارنه قوة واتجاه هذه العلاقة لدى عينه من مريضات سرطان الثدي والأصحاء، وتحديد أيضا الفروق بين المجموعتين في الصفاء الروحي بأبعاده الفرعية، من سن (٦٦:٢٨)

فيبرز سعى الإنسان الفطري نحو السلام الداخلي والبحث عن المعنى كعوامل حاسمة في تجاوز المحن، فقد أثبتت الدراسات والأطر النظرية المتعددة إن القدرة على استيعاب “ الصفاء ” الداخلي سواء كان ذهنيًا أو نفسيًا أو روحيا، تمثل صمام أمان يسمح للعقل والجسم بالعودة إلى حاله التوازن والعافية، هذا الصفاء ليس غيابا للمشكلات، بل هو امتداد للقدرة على التعامل معها من منظور أعمق وأكثر مرونة، وهو ما يشار اليه بالقدرة الفطرية للعقل على التصحيح الذاتي في غياب التدخلات الخارجية المعيقة. (سمارت، ٢٠١٨)

فالحالة النفسية لمريضات السرطان تمر بتحولات فريدة معقدة تتطلب فهما عميقا، وتكتسب اهمجه هذه الجوانب بعدا خاصا لدى النساء المصابات بالسرطان، نظرا لما قد يفرضه المرض من تحديات إضافية تتعلق بالصورة الجسدية، والوظائف الإنجابية، والأدوار الاجتماعية داخل الأسرة والمجتمع، مما يزيد من احتماليه تعرضهن للخطر النفسي والحاجة الملحة للدعم الشامل، وبالرغم من إن أدبيات العلاج النفسي تسلط الضوء مرارا وتكرارا على اهمجه الدعم النفسي، التي تركز بشكل مباشر على تنميته الجوانب الروحية والوجودية الداعمة ، كالتى يؤكد عليها “ فرانكل ” في نظريته عن

العلاج بالمعنى ، والتي ترى في إيجاد معنى الحياه والوصول إلى الصفاء الروحي سبيلا أساسيا لتجاوز المعاناة وتحويلها إلى نمو شخصي. (زخارى، ٢٠٠٤)

وذلك يوضح لنا مهمه علم النفس التي تمدنا بالقدرة على فهم (المعاني) ، والتي تؤثر بها هذه (المعاني) على أفعال البشر ومقدراتهم، وساعد على تحديد المشكلة طبيعة العلاقة بين العقل والجسد فهما تعبير عن الحياه، بل هم مكونات الحياه وحتى نهايتها، فهي علاقه شراكه يوجهه العقل فيها الجسم من اجل تحقيق النمو المشترك والقدرات المشتركة، فأى مشكله تحدث ولو جرح بسيط ، فان الجسم يقوم بمجموعة من الأفعال بطريقه اتوماتيكية حتى يشفى ويصبح سليما مره أخرى، ولكن علينا إن نعرف هنا إن الجسد لا يتحرك وحده في المواجهه، كما انه -العقل- يساعد الجسد عندما يأمره بممارسة أشياء. وبذلك يحافظ على أمان الجسد ويبقيه منيعا، فما بالبنا بمرض مزمن كالسرطان!!! (أدلر، ٢٠٠٥، ص ٤٩-٥٢)

وقد أشارت دراسة إيرانية بعد تحليل التجارب الروحية لمرضى السرطان إلى أن الصفاء الروحي لمرضى السرطان يتحقق بتحقيق السلام الداخلي كاستراتيجية وحلول لتلبية الاحتياجات الروحية، فالمرضى الذين يواجهون تحديات وضغوط يومية تلقائيا يبحثون عن طرق للاسترخاء وتحقيق السلام .. فيذكر مثلا (سلايت واخرون، ٢٠٠٧)

"...أسامح الآخرين ، ليغفر الله لي " . كما يذكر (رسولى و حاتاميبورك، ٢٠٢١)

"....رسالتى السابقة كانت الحياه جميله .لم اقدر ذلك بما فيه الكفاية وقد فعل الله هذا بي ، والان يجب أن أشكر الله كثيرا . وأعلم أن الله سوف يشفيني"

(Khosravani &Nejat,2022)

فهو بداية طريق سرى ممنهج من التطور الروحي الذى لا نهاية له. ونصل اليه بالممارسة والتدريب، ونتائج تتوقف على الطاقة التي تشعها في نفسك ، ومن شروطه التطور والممارسة وعدم التوقف عن التعلم والسرية المتصلة بالاستعانة بخبرات المعلمين لتجنب الخطأ، ان تتعلم كيف تجارى قاعدة التغيير ، وان تجارى الطاقة التي تحدث هذه التغيرات. (محمد، ٢٠٢١، ص ١٩)

كما اتضح بعد التشخيص المبدي و الفحص للكشف عن السرطان لـ(هولندا ورزبيك ٢٠٠٥) بعد تتبع مسارات" الرعاية النفسية والاجتماعية للناجين من السرطان"، إن المرضى يواجهون صعوبة في قبول المرض ويلزمهم مشاعر الكدر النفسي وصعوبة في التكيف مع المرض والسبب راجع إلى فقدان المعنى في الحياة والصراع في قبول المرض، مثلما يهدد تشخيص السرطان إحساس الفرد بمعنى الحياة ويؤثر على غرض حياته وأولوياته. وهنا قد تنتهك تجربة السرطان قدرة الفرد على الاعتقاد بأن الحياة منظمة وذات معنى. (quinto, et al,2022,p1)

لذلك يعتمد تحسين معنى الحياة على (١) الشخصية لان البحث عن المعنى يقودنا حتما في رحلة لاكتشاف وتشكيل انفسنا وصناعه هويتنا، بمزيج من قيمنا وسلوكنا وتجاربنا ومعاناتنا، فنحن مسودة تقريبيه لأنفسنا في المستقبل. و حجاج في الطريق إلى مكان جديد للوجود. (٢) المعاناة بالوقوف على التساؤل الاتي هل من الممكن إنتاج أي خير من الألم والكرب لإعطاء معنى؟ فالإصابة بالمرض لا معنى له في حد ذاته، ولكن يمكن تعويض عدم جدواها من خلال محاوله العثور على المنفعة أو الجانب المشرق الذي ينبسق من حاله البؤس ، فيجب أن نكون ممتتين للمعاناة، لما تجلبه من نمو ما بعد الصدمة من تحسن شخصي و نضج عاطفي ، وتشكيل لا هدا ف اكبر ، والالتزام بمساعدة الآخرين في التعامل مع المعاناة ،فقال فرانكل (المعاناة تتوقف في اللحظة التي نجد فيها المعنى). (Palmer,2021,p24-27)

كما تبين بعد فحص أربعين مقالة تشير إلى تغيرات المعنى في الحياة تأكدنا بأن هناك بعض النظريات الرائدة في التغيير وهما :الأولى نظرية إدارة الموت والإرهاب أو الرعب لـ(فوس وآخرون ،٢٠٠٩):بالتركيز على تأثيرات الوعي بحقيقه الموت، والثانية المناهج المختلفة لمنظورات الوقت لـ (سديكي كادز وآخرون،٢٠١٨): وهي تميل بمطالبه الأفراد بالتفكير في الحياة الماضية أو المستقبل، فقد ندعمهم بإشراكهم في الحنين إلى الماضي مثلا ، والثالثة بالتدخلات النفسية الإيجابية العامة لـ(سيزوسكا وجوربا،٢٠٢١): التي توجه لتنفيذ تدخلات مبينيه على مفاهيم شائعته كالامتنان ،اليقظة الذهنية، السلوك الاجتماعي، والرابعة بمجموعة من المناهج للتعبير

عن أو اكتشاف التماسك أو صنع المعنى لـ(هاجتاد وفوس، ٢٠٢١) بمساعدتهم على التماسك وتوجيههم لالتقاط صور ذات معنى بالانخراط في تجربة الفن والأبداع ، أو وضعهم في ظروف مألوفة أو روتينية أو تقديم محفزات يسهل فهمها (٢٠). كما اظهر(فوس وفيتالي وآخرون ، ٢٠١٥، ٢٠١٨) أن التحليل لستين تجربة إكلينيكية إن المعالجين المرتكزين على المعنى يمكنهم مساعدة العملاء على عيش حياة ذات معنى وإرضاء أكثر، وقبول معطيات الحياة ، وتحمل للقيود الوجودية، فتحسن صحتهم العقلية والجسدية. كما أظهر(فوس، ٢٠١٧) المعالجون خمس مجموعات من الكفاءات مدعمة بالأدلة التجريبية لفاعليتها: الكفاءات المتمحورة حول المعنى، والتقييم، والعلائية، والوجودية، والظواهر التجريبية. (Chan et al,2023,p1-2)

مشكلة الدراسة:

ما زالت تمثل الأمراض المزمنة حدسا جسديا ونفسيا، وتدفع بالمتخصصين في علم النفس إلى محاولة فهم اعمق للتغيرات التي يمر بها المرضى، يثير هذا الواقع فضولنا الاكاديمي والبحثي في استكشاف اعمق طبقات النفس البشرية، سواء من الناحية النفسية الوجودية والروحية أيضا ، فكلا الجانبين يمثل كنزا للباحثين في فهم المشاعر والإدراكات التي تشكل تجربته المرض المؤلمة التي قد تهدد الحياة ، وكيف تؤدي إلى تحولات جذرية في حياة الفرد.

ويبرز بين هذه الحالات، التحدي الذي تواجهه مريضه سرطان الثدي، حيث تواجهه أسئلة وجودية عميقة حول معنى حياتها . غالبا ما تجد نفسها في حوار داخلي مؤلم، تتساءل تساؤلات وجودية "لماذا أنا؟"، إلى تساؤلات تعبر عن صراعاها الداخلي في الرغبة إلى ما كانت عليه من قبل متسائلة: "كيف أعود إلى ما كنت عليه من حياة صفاء وراحة بالنسبة لما أنا عليه الآن؟" ، ومع مرور الوقت ، قد تتمنى إن " تصبح مثل السليمات" .

هذه الرغبة في استعادة حياتها الطبيعية هو ما يدفع المريضة إلى البحث عن ذاتها. إلا أن هذه الرحلة قد تتحول تدريجيا إلى ادراك عميق، حيث تصل المريضة إلى التحول النفسي الإيجابي التي تدخلها في مرحلة الإدراك قائله " المرض فعلا غيرني

للأحسن". هذا التحول من الألم إلى القوة هو ما يدفعنا لاستكشاف اليات التكيف والمرونة.

هنا يبرز دورنا كباحثين ، حيث لا يقتصر هدفنا على رصد هذه المشاعر ، بل يمتد ليشمل محاوله فهم الفروقات والتشابهات بينها وبين حياه الأصحاء. وعلى الرغم من إن معاناه المريضة تمثل مادة دسمة للتحليل النفسي، إلا أننا لا نستبعد إمكانية إن يفاجئنا البحث بنتائج غير متوقعه ، قد تكشف عن تشابه في بعض جوانب معنى الحياه بين المريضات والأصحاء.

خاصة إن التجارب المؤلمة والموجعة قد تكون بداية حقيقة للحظات الصفاء الروحي وتغيير نظرتها وهدفها من الحياه، فتلك اللحظات بمثابة طاقة النور التي تستجد بها المريضة ، وكلما تعمقت في قراتها لذاتها من خلال تجربتها القاسية، كلما أصبح هذا الصفاء وعاد لا يفنى للقوة والراحة، تستلزم به لتجد سلامها الداخلي وسط التحديات.

والتي أشارت إليها دراسة(هايلي وايان، ٢٠١٢) مقدمة بيانات معيارية على مرضى السرطان حديثي التشخيص حول مشكله البحث الحالي ،وتؤكد أيضا الدراسة على إن المساهمة الإكلينيكية لهذا التقييم التفصيلي يحسن من صحه المرضى الجسمية وعلاقتهم الاجتماعية. (Whitford & Olver, 2012)

لذلك يهدف البحث الحالي إلى استكشاف ومقارنه أبعاد الصفاء الروحي وأبعاد معنى الحياه لدى مريضات سرطان الثدي مقارنه بالأصحاء، في محاوله لفهم كيف يمكن أن يؤثر المرض على هذه الجوانب الجوهرية، وكيف يمكن للفرد أن يجد حياته وسلامة الداخلي وسط التحديات.

بالرغم ن قله الدراسات في نقطة البحث الحالي إلا إن هناك أشاره من دراسة (الينا وآخرون، ٢٠١٥) وأوضحت أن مستوى المعنى والهدوء (المتمثل في الصفاء الروحي في البحث الحالي) لدى المريضات محددة سرطان المبيض كان مرتبطاً بشكل إيجابي بجودة حياتهن وصحتهن العقلية. فكلما كان مستوى المعنى والهدوء أعلى، كانت جودة الحياه والصحة العقلية أفضل. فكان لديهم مستويات قلق واكتئاب اقل ، ومستويات اعلى من الأمل ، والقدرة على التأقلم مع المرض. (Brown et al., 2015)

بالنظر إلى ندرة الأبحاث التي تقارن بشكل مباشر أبعاد معنى الصفاء الروحي ومعنى الحياة بين مريضات سرطان الثدي والأصحاء، على الرغم من الإشارات الداعمة في دراسات مثل (هايلي واين، ٢٠١٢)، -دراسة (الينا وآخرون، ٢٠١٥)، -دراسة (باولو وآخرون، ٢٠١٨)، -دراسة (تيريزا فيلوسا، ٢٠٢٣). إلى أهمية هذه الأبعاد، تبرز مشكلة الدراسة في التساؤل المحوري : هل يمكن إن تكون تجربة المرض المزمّن بوابه لتحقيق مستوى اعلى من الصفاء الروحي ومعنى الحياة مقارنة بمن لم يمرون بتلك التجربة.

ومن ثم تمثلت مشكله هذه الدراسة في التساؤلات التالية :-

١- هل يوجد ارتباط دال بين أبعاد الصفاء الروحي وأبعاد معنى الحياة لدى مريضات سرطان الثدي والأصحاء؟

٢- هل توجد فروق داله إحصائية بين مريضات سرطان الثدي والأصحاء في أبعاد الصفاء الروحي؟

٣- هل توجد فروق داله إحصائية بين مريضات سرطان الثدي والأصحاء في أبعاد معنى الحياة؟

أهداف الدراسة:

تهدف هذه الدراسة إلى المقارنة بهدف الكشف عن الفروقات بين مريضات سرطان الثدي والنساء الأصحاء في أبعاد الصفاء الروحي وأبعاد معنى الحياة. أهمية الدراسة:

أولاً :- الأهمية النظرية: متمثلة في ندرة دراسات التي قارنت بين مريضات سرطان الثدي والأصحاء في ضوء متغيرات الدراسة الحالية، كما هامه في التعرف على الآليات النفسية لمريضه سرطان الثدي التي تتبعها في تجربتها للتكيف مع المرض .
ثانياً :- الأهمية التطبيقية : زيادة الوعي بأهمية الجوانب النفسية والروحية في حياة المريضة، كما تساعد مقدمي برامج الدعم من خلال نتائج الدراسة.

التعريفات الإجرائية لمتغيرات الدراسة:

أولاً: الصفاء الروحي

- هو صفة روحية يتضمن القوة الداخلية والإيمان بالتفاعل بين الأحداث الداخلية والخارجية. (Boyd-Wilson, McClure, & Walkey, 2004,p31)

وهناك من عرف الصفاء الروحي في ضوء السعادة هو باعتبارها نعيم مقترن بتحقيق الذات فالسعادة، والحياة السعيدة، والقدرة على الشعور بالراحة فيها، كلها عوامل في تحقيق السكينة (وكر، ٢٠١٥)، وقد يشار إليه أحيانا بمصطلحات أخرى كراحه البال لدى (لى وأخرون ٢٠١٣)، والسكينة ل(رورتس واسبي، ١٩٩٣)، والطمأنينة (الدرى والحكاك، ٢٠١١) و(والكر، ٢٠١٥)، وتضمن القلب والسكينة الروحية ل(بودياستوتي، ٢٠١٨) و(رشدى وأخرون، ٢٠١٨). (Rusdi et al., 2022,P83)

ويعرفه الباحثان إجرائيا بأنه مجموع درجات الفرد على المقياس المستخدم والتي تعكس القبول والملاذ الداخلي والثقة.

ثانياً : معنى الحياة

هناك من رائها حاله من البحث ،فالمعنى هنا ظاهرة وجودية مصاحبه للإنسان طول مراحل حياته، فليس لها علاقة بالعمر ولا الجنس ولا المستوى الاجتماعي ولا الاقتصادي ، وبالتالي يختلف المعنى هنا من شخص لآخر، بل وداخل الفرد نفسه من حين لآخر، وهنا يصل الفرد لحاجه من اثنين، أما يحقق الشخص المعنى من حياته وبذلك يحقق وجوده الأصيل ،أما يعجز عن الوصول لتحقيق المعنى من حياته ، وبذلك يصل إلى حاله تسمى بالفراغ الوجودي أو الخواء المعنوي. (عبد الحليم ، ٢٠١٠، ص٣٣٩)

-وقد تكون هي مجرد الإحساس والهدف بمعنى الحياة ، أي انخفاض خواء المعنى (محمد، ص١٤١)

ويعرفه الباحثان إجرائيا بأنه مجموع درجات الفرد على المقياس المستخدم والتي تعكس الهدف من الحياة والرضا عنها والتسامي الذاتي والمسئولية اتجاه الحياة.

الدراسات السابقة

أشارت دراسة (روسيلا ماتيا وآخرون، ٢٠٢٢) والتي تهدف إلى المراجعة المنهجية إلى فحص العلاقة بين إيجاد المعنى في الحياة وتقبل مرض السرطان لدى المرضى، وشملت العينة ثلاثة دراسات فقط تم اختيارها من أصل ٤٩٠٧ سجل، وكانت العينة الكلية تتألف من ٤٦٤ امرأة مصابة بالسرطان. وتم البحث في قواعد بيانات طبيبه و نفسية (CINAHL, MEDLINE, PSYCINFO, SCOPUS) في نتائجها الرئيسية للدراسات الثلاثة وجود ارتباطات إيجابية بين معنى الحياة وتقبل السرطان ، مما يشير إلى إن وجود معنى في الحياة يرتبط بتقبل أفضل للمرض، وتراوحت قوة الارتباط من (٠.١٩) إلى (٠.٣٨) ، على الرغم من الارتباط الإيجابي، لم تجد النتائج إن معنى الحياة يتنا بتقبل المرض.

فخلصت الدراسة إلى إن العلاقة بين معنى الحياة وتقبل السرطان لم تبحث بشكل كاف، وإن هناك حاجة ماسة لمزيد من الدراسات لفهم هذه العلاقة بشكل اعمق.

- دراسة (سيما أوستونداغ وآخرون ، ٢٠٢٤) حيث كان هدفها تحديد ومقارنة احتياجات الرعاية الروحية لمرضى السرطان ومقدمي الرعاية لهم. على عينه مكونه من الاتراك (١٠٢) مريض بالسرطان مسجلين في وحدة الرعاية المنزلية بالمستشفى ، بالاضافه إلى (١٠٢) من مقدمي الرعاية لهم وتم جمع البيانات باستخدام استمارة معلومات شخصيه ومقياس احتياجات الرعاية الروحية (Car Needs Inventory Spiritual) ، وكانت النتائج كالآتي إن مرضي السرطان بحاجة إلى رعاية روحية أكثر بكثير من مقدمي الرعاية لهم. كما اختلفت احتياجات المرضى من الرعاية الروحية بشكل كبير بناء على حالتهم الوظيفية، لم يكن لعوامل مثل الجنس، المستوى التعليمي، والحالة الاجتماعية أي تأثير كبير على احتياجات الرعاية الروحية للمشاركين، كما وجدت في الدراسة علاقه ارتباطية إيجابية ومعتدلة بين احتياجات المرضى واحتياجات مقدمي الرعاية.

- وما توصلت إليه دراسة (مبشر قند وسخجيت كورو ، ٢٠٢٤) ، وكان هدفها فحص تأثير الدين والروحانية على جودة حياة مرضى السرطان ، وقد استخدمت الدراسة التحليل البيليويمترى لتحقيق ذلك ، وهو أسلوب منهجي يعتمد على تحليل عدد كبير من الأوراق البحثية المنشورة في هذا المجال. على عينة (ليست اشخاص) بل كانت عبارته عن مجموعة من الوثائق العلمية. قامت الدراسة بتحليل ٤٠٦ وثيقة (مقالات ومراجعات وفصول كتب) تم جمعها من قاعدة بيانات "سكوبس" لتقييم الاتجاهات البحثية في هذا الموضوع. وأكدت النتائج إن المراجعة الشاملة للأدبيات إن الروحانية ، والتدين، والتفاؤل هي عوامل حيوية تساعد في تحسين جودة حياة مرضى السرطان وتسهيل رحله علاجهم ، كما توصلت الدراسة إلى إن هذه المفاهيم تساهم في التخفيف من المشكلات النفسية التي يواجهها المرضى ، مثل الاكتئاب والقلق.

- دراسة (كيونغ وشين، ٢٠٢٠) والتي قامت بالمقارنة لتصورات الرعاية الروحية بين ثلاثة اطراف مختلفة: (١) مرضى السرطان في مرحلة تهدد حياتهم. (٢) مقدمو الرعاية الأسرية الأساسيون لهم. (٣) ممرضو الرعاية التلطيفية ومأوى المحتضرين. كما تضمنت عينة الدراسة ثلاثة مجموعات من المشاركين بهدف الحصول على رؤية شاملة من جميع الأطراف المعنية مباشرة بالرعاية: المرضى، العائلة، ومقدمي الرعاية المحترفين. باستخدام أسلوبين رئيسيين لجمع وتحليل البيانات ، الأول الاستبيان المنظم لجمع البيانات الكمية . وتحليلها باستخدام التحليل الاحصائي. والبيانات غير المنظمة والتي تم جمعها من خلال أسئلة مفتوحة. وتم تحليلها باستخدام تحليل المحتوى لاستخراج المواضيع الرئيسية. وعن النتائج بالنسبة للاستبيان (البيانات الكمية) ظهر إن المجموعات الثلاثة تتفق في إن الرعاية الروحية ترتبط بأتاحه الفرصة للتأمل الداخلي، مساعدة المريض على إيجاد المعنى، تشجيع الأمل، الاستماع إلى المريض والتواجد معه، أما تحليل المحتوى (البيانات النوعية) اظهر خمسة مواضيع رئيسية من المقابلات والملاحظات: الاهتمام بصدق، تقوية الموارد الروحية، (للجميع)، تخفيف الألم

الجسدي وعدم الراحة(فقط لدى المرضى ومقدمي الرعاية الأسرية)،تحسين خدمة الرعاية الروحية(لجميع)، التعاون متعدد الأوجه(فقط لدى المرضى)، وتشير الخلاصة إلى إن الرعاية الرحيه يجب إلا تقتصر على الجانب الديني، بل يجب إن تلبى الاحتياجات الوجودية الداخلية للمرضى مثل التعاطف، تشجيع الأمل، إيجاد المعنى في ظروفهم.

مراجعة الدراسات السابقة:

تكشف المراجعة المنهجية لمجموعه من الدراسات الحديثة(٢٠٢٠-٢٠٢٤) التي تناولت مرضى السرطان إن المعنى في الحياه والصفاء الروحي(الاحتياجات الروحية) تمثل عوامل حاسمة في التكيف مع المرض وتحسين جودة الحياه. ففي حين أثبتت الدراسات وجود ارتباطات إيجابية بين وجود المعنى وتقبل المرض، شددت في الوقت ذاته على الحاجة الماسة لمزيد من البحث لتعميق فهم هذه العلاقة. كما أكدت النتائج بشكل قاطع إن مرضى السرطان لديهم احتياجات روحية اعلى بكثير من مقدمي الرعاية لهم، وأن الروحانية والتدين والتفاؤل تعمل كعوامل حيوية لتخفي المشكلات النفسية المصاحبة للمرض. وتشير هذه الأبحاث مجتمعة إلى ضرورة توسيع مفهوم الرعاية الروحية ليشمل الجوانب الداخلية للمريض(مثل إيجاد الأمل والتعاطف وإتاحة الفرصة للأمل)، مؤكدة إن دمج الدعم الروحي والوجود هو مكون أساسي وضروري للرعاية الشاملة لمرضى السرطان.

فروض الدراسة

- يوجد ارتباط دال بين أبعاد الصفاء الروحي وأبعاد معنى الحياه لدى مريضات سرطان الثدي والأصحاء.
- توجد فروق داله إحصائية بين مريضات سرطان الثدي والأصحاء في أبعاد الصفاء الروحي.
- توجد فروق داله إحصائية بين مريضات سرطان الثدي والأصحاء في أبعاد معنى الحياه.

منهج وإجراءات الدراسة:

المنهج: تم الاعتماد على المنهج الوصفي المقارن.

الإجراءات :

عينة الكفاءة السيكو مترية :

حيث استخدمت هذه العينة بهدف التعرف على الخصائص السيكو مترية للمقاييس المستخدمة في الدراسة، حيث تكونت فيها العينة من (٢١) مريضه سرطان الثدي التي يتلقين العلاج والدعم النفسي بمؤسسه بهيه بمدينة الشيخ زايد ،والتي تتراوح أعمارهم من (٦٦:٢٨) (بمتوسط ٤٥,٢٤) وانحراف ١٠.٤٥٩)، و (٢١) من النساء الأصحاء ، اللاتي تتراوح أعمارهم من (٦٠:٢٨) (بمتوسط ٤١.٤٣ و انحراف ٩.١١٩)، واختيرت العينة من مستويات تعليمية مختلفة (من مؤهل متوسط :عالي) مع تكافؤ المجموعة التجريبية مع مراعاة التشابه مع المجموعة التجبيه في الظروف الحياتية قدر الإمكان.

أما العينة الأساسية تكونت من (٦٠) من السيدات منهم (٣٠) مريضات سرطان الثدي تتراوح أعمارهم ما بين (٦٦:٢٨)، بمتوسط (٤٣.٢٠) وانحراف معياري (٩.٦٨) و (٣٠) من الاصحاء اللاتي تتراوح أعمارهم من (٦٠:٢٨) بمتوسط (٣٨.٩٣) وانحراف معياري (٩.٠٠) ، وتم اختيارهم في ضوء التكافؤ في العمر والمستوى التعليمي (متوسط -عالي) والحالة الاجتماعية(عزباء -متزوجه -منفصله) كما توضحه الشروط الآتية:-

وعن شروط اختيار عينه مريضات سرطان الثدي

-من مريضات سرطان الثدي.

-من المتزوجات أو غير المتزوجات حاليا ولكن سبق لهن الزواج. ولديهم قدر

من المستوى التعليمي.

-من المريضات التي يتلقين علاجاً طبياً حالياً واحد أو أكثر .

-عدم تلقى أي علاجات نفسيه حالياً.

-مدة مرضهم من ٦ اشهر إلى ٥ سنوات.

أما شروط اختيار عينه الأصحاء

- فكانت مجموعه السيدات الراشدات الأصحاء الخالين من أي أمراض جسميه ومتكافئين مع مجموعه المريضات .

- من المتزوجات وغير المتزوجات حاليا و سبق لهن الزواج. ولديهم قدر من المستوى التعليمي .

- خلوهم من أي أمراض مزمنة أو خطيره.

- عدم تلقى أي علاجات أو تدخلات نفسيه من قبل .

أدوات الدراسة :

اعتمدت الدراسة على الأدوات التالية:

((مقياس الصفاء الروحي)) إعداد لروبرتس واسبي(١٩٩٣) وقاما الباحثين

بتعريبه.

الخصائص السيكومترية للصفاء الروحي للدراسة الحالية:

الطريقة الأولى

جدول (١)

صدق الاتساق الداخلي من خلال حسابات معاملات ارتباط البنود بالأبعاد على مقياس

الصفاء الروحي لمريضات السرطان

البعد الأول:- القبول

رقم البند	٦	٧	٨	٩	١٠	١٣	١٥	١٨	٢١	٢٢
معاملات	٠,٥٢١	٠,٥٨٩	٠,٦١٣	٠,٧٠٩	٠,٨١٨	٠,٥٤٥	٠,٧٠٤	٠,٤٩٢	٠,٣٣٣	٠,٦٥٢
الارتباط	٠,١٥	٠,٠٥	٠,٠٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠١	٠,٠٠	٠,٠٢٣	٠,١٤٥	٠,٠١

داله عند مستوى ٠,٥

داله عند مستوى ٠,١

البعد الثاني:- الملاذ الداخلي

رقم البند	١	٢	٥	١١	١٢	١٤	١٧	١٩
معاملات	٠,٥٩٧	٠,٦٥٨	٠,٦٢٦	٠,٩٣٥	٠,٨١٧	٠,٧١٠	٠,٨٤٧	٠,٨٤٥
الارتباط	٠,٠٤	٠,٠١	٠,٠٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠

داله عند مستوى ٠,٥

داله عند مستوى ٠,١

البعد الثالث:- الثقة

رقم البند	٣	٤	١٦	٢٠
معاملات	٨٤٩	٨١٣	٨٢١	٧٠١
الارتباط	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠

داله عند مستوى ٠٠٥

داله عند مستوى ٠٠١

فكانت كل البنود على الأبعاد داله عدا البند (٢١) في البعد الأول فقط

جدول (٢)

صدق الاتساق الداخلي من خلال حسابات معاملات ارتباط الأبعاد بالدرجة الكلية لمقياس الصفاء الروحي لمريضات السرطان

الأبعاد	الأول	الثاني	الثالث
معاملات	٩١٤	٩١٣	٧٤٩
الارتباط	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠

داله عند مستوى ٠٠٥

داله عند مستوى ٠٠١

جدول (٣)

صدق الاتساق الداخلي من خلال حسابات معاملات ارتباط البنود بالدرجة الكلية على مقياس الصفاء الروحي لمريضات السرطان

البنود	معاملات الارتباط	البنود	معاملات الارتباط
١	٥٧٦	١٢	٧٤٢
٢	٦٢٣	١٣	٤٩٦
٣	٥٤٢	١٤	٧٢٤
٤	٧٣٥	١٥	٥٩٠
٥	٤٣٦	١٦	٥٦٢
٦	٤٧٢	١٧	٨٢٢
٧	٥٨٧	١٨	٣١٦

١٦٣				٠٠٥	
٧٦٧	١٩			٤٤٣	٨
٠٠٠				٠٠٤٤	
٥٣٨	٢٠			٥٦٩	٩
٠١٢				٠٠٧	
٤٤٦	٢١			٧٥٥	١٠
٠٠٤٣				٠٠٠	
٧٧٧	٢٢			٨٢٣	١١
٠٠٠				٠٠٠	

داله عند مستوى ٠٠١

داله عند مستوى ٠٠٥

ومن الجدول السابق نلاحظ معاملات ارتباط مرتفعة للبند الأتية)
(٤,٧,١١,١٢,١٥,١٦,١٧,١٩,٢٢

والتي معاملاتها (٠.٧٣٥, ٠.٥٨٧, ٠.٧٥٥, ٠.٨٢٣, ٠.٧٢٤, ٠.٥٩٠

٠.٥٢٥, ٠.٨٢٢, ٠.٧٦٧, ٠.٧٧٧) ، مع قيمة دلالة ٠.٠٠٠ ، مما يشير إلى

إن هذه البنود ترتبط بشكل كبير ودال إحصائيا بالمتغير الذي تم قياسه.

كما إن هناك بنود ذات الارتباطات المتوسطة مثل البند ١ (٠.٠٥٦٧, ٠.٠٠٠١) ،

البند ٣ (٠.٠٥٤٢, ٠.٠٠١١) ، البند ٥ (٠.٠٤٣٥, ٠.٠٠٤٨) ، البند ٦ (٠.٠٤٧٢, ٠.٠٠٣١،

البند ٨ (٠.٠٤٤٣, ٠.٠٠٤٨) ، البند ٩ (٠.٠٥٦٩, ٠.٠٠٠٠) ، البند

١٣ (٠.٠٤٩٨, ٠.٠٠٢٢) ، البند ١٤ (٠.٠٧٢٤, ٠.٠٠٠٠) ، البند ٢٠ (٠.٠٥٣٨, ٠.٠٠١٢،

البند ٢١ (٠.٠٤٤٦, ٠.٠٠٣٤) تظهر ارتباطات متوسطة إلى قوية وهى داله

إحصائيا عند مستوى دلالة ٠.٠٠٥ أو ٠.٠٠١ .

أما البنود ذات الارتباطات الضعيفة أو غير الدالة إحصائيا ، فبالرغم من إن

معظم البنود تظهر دلالة أخصائية إلا إن هناك بنودا واحدا (البند ١٨) يظهر معامل

ارتباط منخفض (٠.١٦٣) . هذه القيمة اكبر من ٠.٠٠٥ و ٠.٠٠١ ، مما يشير إلى إن

الارتباط لهذا البند ليس دالا أخصائيا عند المستويات التقليدية (٠.٠٠٥ أو ٠.٠٠١) .

هذا يعنى إن العلاقة بين البند ١٨ والمتغير المقاس قد تركز ضعيفة جدا أو عشوائية.

نستنتج من الجدول إن معظم البنود (٢١ من اصل ٢٢) لها ارتباطات داله

إحصائيا بالمتغير المقاس ، مما يدل على اتساق داخلي جيد ، البند رقم ١٨ هو

الاستثناء الوحيد الذي لا يظهر ارتباطا دالا إحصائيا ، وقد يتطلب هذا البند إلى مراجعه أو إعادة صياغة. وبشكل عام تدهم هذه النتائج صلاحية البنود واتساقها الداخلي.

الطريقة الثانية : طريقه المقارنة الطرفية

جدول (٤)

يوضح دلالة الفروق بين متوسطات درجات افراد العينة على أبعاد مقياس الصفاء الروحي لمريضات السرطان (ن=٢١)

المقياس	المجموعة	العدد	متوسط	الانحراف المعياري	قيمة T	الدلالة
القبول	ذوى الدرجات المنخفضة (الارباعى الأدنى)	٧	٥٧.٢٢	٩٩٦.٥	-٠.١٢٤٦	0.000
	ذوى الدرجات المرتفعة (الارباعى الأعلى)	٧	٣٧.٥٧	٢,٧٦٠		
الملاذ	ذوى الدرجات المنخفضة (الارباعى الأدنى)	٧	٥٧.١٥	٣٥٣.٤	-٨,٢٠٢	0.000
	ذوى الدرجات المرتفعة (الارباعى الأعلى)	٧	٣٢.٤٣	٣,٢٥٩		
الثقة	ذوى الدرجات المنخفضة (الارباعى الأدنى)	٧	١٤.١٣	١٠٠.٤	-٣,٨٦٢	0.000
	ذوى الدرجات المرتفعة (الارباعى الأعلى)	٧	١٩.٢٩	٩٥١,٤		
الصفاء الروحي ككل	ذوى الدرجات المنخفضة (الارباعى الأدنى)	٧	52.71	12.526	541-٠.6	0.000
	ذوى الدرجات المرتفعة (الارباعى الأعلى)	٧	86.86	815.5		

يتضح من الجدول السابق ومن خلال الفروق التي توصلت إليها الباحثة في مجموع درجات الأفراد للمقياس ككل يتضح من ذلك صدق المقياس إن قيمة التاء داله إحصائيا عند مستوى ٠.٠٠١، مما يدل على تمتع المقياس بصدق تمييزي قوى، وهذا يؤكد صلاحيته للتطبيق، تم التأكد من ثبات مقياس الصفاء الروحي بعده طريقه كما موضح بالجدول التالي .

جدول (٥)

يوضح ثبات الصفاء الروحي بطريقة الفاكرونباخ والتجزئة النصفية

الأبعاد	عدد البنود	ثبات الفاكرونباخ	التجزئة النصفية
الأول	١٠	٠٧٨٩	٠٩٤٦
الثاني	٨	٠٨٩٥	٠٨٦٨
الثالث	٤	٠٧٩٤	٠٧٣٣

ومن الجداول السابقة يتبين وجود معدلات ثبات مرتفعة لبنود مقياس الصفاء الروحي باستخدام الطريقتين مما يشير إلى تمتع المقياس بدرجة من الثبات والصدق تؤهله للاستخدام لدى فئة مريضات السرطان في هذه الدراسة -مقياس ((معنى الحياة)) إعداد (رييحة محمود ٢٠٢٣) الخصائص السيكومترية لمقياس معنى الحياة الطريقة الأولى

جدول (٦)

صدق الاتساق الداخلي من خلال حسابات معاملات ارتباط البنود مع الأبعاد الفرعية على مقياس معنى الحياة
البعد:- الأول

رقم البند	١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨
معاملات	٠٧٤٣	٠٨٤٢	٠٦٦١	٠٦٦٢	٠٧٩٤	٠٦٤٢	٠٦٤٢	٠٧٢٦
الارتباط	٠٠٠٠	٠٠٠٠	٠٠٠١	٠٠٠١	٠٠٠٠	٠٠٠٢	٠٠٠٢	٠٠٠٠

داله عند مستوى ٠٠١

داله عند مستوى ٠٠٥

البعد :- الثاني

رقم البند	٩	١٠	١١	١٢	١٣	١٤	١٥	١٦
معاملات	٠٧٩١	٠٧٥٥	٠٦٢١	٠٨٦٩	٠٦٤٨	٠٧٥٦	٠٥٢٥	٠٤٨٠
الارتباط	٠٠٠٠	٠٠٠٠	٠٠٠٣	٠٠٠٠	٠٠٠١	٠٠٠٠	٠٠١٥	٠٠٢٧

داله عند مستوى ٠٠١

داله عند مستوى ٠٠٥

البعد :- الثالث

رقم البند	١٧	١٨	١٩	٢٠	٢١	٢٢	٢٣	٢٤
معاملات	٧١٠،	٨١٩،	٨٩٢،	٤٦٨،	٨٠٦،	٨٦٢،	٨٦٠،	٥٥٥،
الارتباط	٠٠٠،	٠٠٠،	٠٠٠،	٠٣٣،	٠٠١،	٠٠٠،	٠٠٠،	٠٠٩،

داله عند مستوى ٠٠٥، داله عند مستوى ٠٠١،

البعد :- الرابع

رقم البند	٢٥	٢٦	٢٧	٢٨	٢٩	٣٠	٣١	٣٢
معاملات	٥٣٥،	-٠٦٠،	٥١٩،	٧٧٤،	٨٩٠،	٧٣٧،	٧٧٨،	٦٣٨،
الارتباط	٠١٣،	٧٩٧،	٠١٦،	٠٠٠،	٠٠٠،	٠٠٠،	٠٠٠،	٠٠٢،

داله عند مستوى ٠٠٥، داله عند مستوى ٠٠١،

جدول (٧)

صدق الاتساق الداخلي من خلال حسابات معاملات ارتباط الأبعاد بالدرجة الكلية لمقياس معنى الحياة

لمريضات السرطان

الأبعاد	الأول	الثاني	الثالث	الرابع
معاملات	٧٩٥،	٨٢٧،	٧٨١،	٧٥٣،
الارتباط	٠٠٠،	٠٠٠،	٠٠٠،	٠٠٠،

داله عند مستوى ٠٠٥، داله عند مستوى ٠٠١،

يتضح من الجداول السابق حول ارتباط البنود بالأبعاد إن هناك ارتباطات مرتفعة للبنود الأتية (١، ٢، ٥، ٨، ٩، ١٠، ١٢، ١٤، ١٧، ١٨، ١٩، ٢٢، ٢٣، ٢٢٨، ٢٩، ٣٠، ٣١) والتي معاملاتها (٧٧٨، ٧٣٧، ٨٩٠، ٧٧٤، ٨٦٠، ٨٦٢، ٨٩٢، ٨١٩، ٧١٠، ٧٥٦، ٨٦٩، ٧٥٥، ٧٩١، ٧٢٦، ٧٩٤، ٨٢٤، ٧٤٣،)، مع قيمه دلالة ٠٠٠٠، مما يشير إلى إن هذه البنود ترتبط بشكل كبير ودال بالبعد الذى تم قياسه، كما إن هناك بنود ذات ارتباطات متوسطة مثل البند ٣٢ (٦٣٨، ٠٠٢،)، البند ٢٧ (٥١٩، ٠٠١٦)، البند ٢٥ (٥٣٥، ٠٠١٣)، البند ٢٤ (٥٥٥، ٠٠٠٩)، البند ٢١ (٨٠٦، ٠٠٠١)، البند ٢٠ (٤٦٨، ٠٠٣٣)، البند ١٦ (٤٨٠، ٠٠٢٧)، البند ١٥ (٥٢٥، ٠٠١٥)، البند ١٣ (٦٤٨، ٠٠٠١)، البند ١١ (٦٢١، ٠٠٠٣)، البند

٧(٠.٠٠٢،.٦٤٢)البند ٦(٠.٠٠٢،.٦٤٢) (البند ٤(٠.٠٠١،.٦٦٢) فتظهر تلك البنود ارتباطات متوسطة وهى داله إحصائيا عند مستوى دلالة ٠.٠٠٥ أو ٠.٠٠١

فيتضح من الجداول إن معظم البنود (٣١ من اصل ٣٢) لها ارتباطات داله إحصائيا بالأبعاد التي تنتمى إليها، مما يدل على اتساق داخلي جيد باستثناء البند (٦ ٢) الوحيد الذى لا يظهر ارتباطا دالا إحصائيا ، وقد يتطلب هذا البند مراجعه أو إعادة صياغة ،كما اكد جدول (٦) على الارتباطات القوية بين اتساق الأبعاد الأربعة بالمقياس مع قيمه دلالة ٠.٠٠٠٠. وبشكل عام تدعم النتائج صلاحية البنود واتساقها الداخلي

الطريقة الثانية

جدول(٨)

يوضح دلالة الفروق بين متوسطات درجات أفراد العينة على أبعاد مقياس معنا
الحياه لمريضات السرطان (ن=٢١)

المقياس	المجموعة	العدد	متوسط	الانحراف المعياري	قيمته T	الدلالة
الهدف من الحيا	ذوى الدرجات المنخفضة (الارباعى الأدنى)	٧	١٣.٢٩	١.٩٧٦	٩,٣٢١-	0.000
	ذوى الدرجات المرتفعة (الارباعى الأعلى)	٧	٢٢.٦٨	١,٨٦٤		
الرضا عن الحياة	ذوى الدرجات المنخفضة (الارباعى الأدنى)	٧	١٠.٨٦	١.٦٧٦	٧,٦٥١-	0.000
	ذوى الدرجات المرتفعة (الارباعى الأعلى)	٧	١٩.٧١	٢,٥٦٣		
تحمل المسؤولية	ذوى الدرجات المنخفضة (الارباعى الأدنى)	٧	١٣.٥٧	٣.٥٠٥	٦,٩٩٨-	0.000
	ذوى الدرجات المرتفعة (الارباعى الأعلى)	٧	٢٣.١٤	.٩٠٠		
التسامي	ذوى الدرجات المنخفضة (الارباعى الأدنى)	٧	١٦.٠٠	٢.٥٨٢	٥,٥٨٢-	0.000
	ذوى الدرجات المرتفعة (الارباعى الأعلى)	٧	٢٢.١٤	١,٣٤٥		
المعنى الحياه ككل	ذوى الدرجات المنخفضة (الارباعى الأدنى)	٧	52.71	6.594	6,794-	0.000
	ذوى الدرجات المرتفعة(الارباعى الأعلى)	٧	٨٥.٢٩	٨٢,٦١		

يتضح من الجدول السابق ومن خلال الفروق التي توصلت إليها الباحثة في

مجموع درجات الأفراد للمقياس ككل يتضح من ذلك صدق المقياس، و إن قيمة التاء داله إحصائيا عند مستوى ٠٠,٠١ مما يدل على تمتع المقياس بصدق تمييزي قوى، وهذا يؤكد صلاحيته للتطبيق، تم التأكد من ثبات مقياس معنى الحياه بعده طرقه كما موضح بالجدول التالي

جدول (٩)

يوضح ثبات معنى الحياه بطريقه الفاكرونباخ والتجزئة النصفية

الأبعاد	عدد البنود	ثبات الفاكرونباخ	التجزئة النصفية
الأول	٨	٨٥٩،	٩٠١،
الثاني	٨	٨٢٩،	٨٨٤،
الثالث	٨	٨٨٤،	٨٧٨،
الرابع	٨	٦٩٦،	٧٠٦،

ومن الجداول السابقة يتبن وجود معدلات ثبات مرتفعة لبنود مقياس معنى الحياه باستخدام الطريقتين مما يشير إلى تمتع المقياس بدرجة من الثبات والصدق تؤهله للاستخدام لدى فئة مريضات السرطان في هذه الدراسة

تطبيق أدوات الدراسة:

أجريت الدراسة خلال شهر أغسطس ٢٠٢٥ حيث تم تطبيق مقاييس الدراسة وهما ال صفاء الروحي و معنى الحياه.

الأساليب الإحصائية:

تم استخدام الفا كرونباخ واختبار التي تيست و تحليل التباين المتعدد وحجم تأثيره ومعامل ارتباط برسون واختبار فيشر لمقارنه معاملات الارتباط .

نتائج ومناقشة الفرض الأول

(١) توجد فروق ذات دلالة إحصائية على أبعاد الصفاء الروحي وأبعاد معنى الحياه بين مريضات السرطان والأصحاء .

وللتحقق من الفرض

وللتحقق من تلك الفرضية ، تم أولاً استخدام تحليل التباين المتعدد كما موضح بالجدول التالي :

جدول (١٠)

نتائج تحليل التباين المتعدد لدلالة الفروق في متوسطات استجابات المريضا والأصحاء حول أبعاد الصفاء الروحي وأبعاد معنى الحياة

قيمه(ف)	درجه الحرية	قيمه الدلالة	حجم التأثير
١.٩٧٨	(f(٧,٥٢	٠.٠٧٦	٠.٢١٠

ينضح من جدول (١٠) عدم وجود دلالة إحصائية كليه لمتوسطات المجموعتين (٠.٠٧٦) عند مستوى دلالة ٠.٠٠٥ .

إلا إن حجم التأثير الكبير (٠.٢١٠) يوجب الانتباه إلى الدلالة العلمية لهذه الفروق لذلك قمنا بعمل مصفوفة ارتباط لكلا من مجموعتي المريضا ومجموعه الأصحاء كما يوضح جدول(١١)كالتالي:

جدول (١١)

معاملات الارتباط بين درجات أفراد عينة الدراسة على أبعاد الصفاء الروحي وأبعاد معنى الحياة للمريضا(ن=٣٠)

الأبعاد	القبول	الملاذ	الثقة	الصفاء ككل	الهدف	الرضا	المسنولية	التسامي	الحيا ككل
القبول	١	٠.٦٦٨	٠.٣٦٨	٠.٨٨٦	-٠.١١٣	-٠.٠٢٢	-	174.	-٠.٠٢٢
	٣٠	٠.٠٠٠	٠.٠٣٠	٠.٠٠٠	٠.٥٥١	٠.٦٠٦	٠.٣١٨	٠.٣٥٧	٩٠.٦
	٣٠	٣٠	٣٠	٣٠	٣٠	٣٠	٣٠	٣٠	٣٠
الملاذ	٠.٦٦٨	١	٠.٤٣٩	٠.٨٩٤	٠.٠٤٢	٠.٠٦٨	-	252-	٠.٠٧٢
	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠١٥	٠.٠٠٠	٠.٨٢٦	٠.٧٢١	٠.٤٤٣	٠.١٧٩	٧٠.٦
	٣٠	٣٠	٣٠	٣٠	٣٠	٣٠	٣٠	٣٠	٣٠
الثقة	٠.٣٩٦	٠.٤٣٩	١	٠.٦٤٥	-٢٨٢	488.	٠.٢٩٠	-٠.٣٧٧	463.
	٠.٠٣٠	٠.٠١٥	٣٠	٠.٠٠٠	١٣١.٣٠	٠.٠٠٦	٠.١١٩	٠.٠٤٠	٠.٠١٠
	٣٠	٣٠	٣٠	٣٠	٣٠	٣٠	٣٠	٣٠	٣٠
الصفاء الروحي ككل	٠.٨٨٦	٠.٨٩٤	٠.٦٥٤	١	٠.١٠٦	102.	-٠.٠٥٢	٠.٢٩٥-	161.
	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٣٠	٠.٥٧٩	٠.٥٩٢	٠.٧٨٦	٠.١١٣	٠.٣٩٥
	٣٠	٣٠	٣٠	٣٠	٣٠	٣٠	٣٠	٣٠	٣٠

الهدف	113.	0.042	282.	106	1	0.055	0.330	0.466	0.788
	0.051	0.826	0.131	0.059	30	0.001	0.070	0.009	0.000
	30	30	30	30		30	30	30	30
الرضا	-0.022	0.068	0.488	0.102	0.055	1	0.411	0.366	0.780
	0.909	0.721	0.006	0.092	0.001	30	0.024	0.047	0.000
	30	30	30	30	30		30	30	30
المسئولية	0.189	-0.140	0.290	0.052	0.330	0.411	1	0.066	0.703
	0.318	0.443	0.119	0.786	0.070	0.024	30	0.001	0.000
	30	30	30	30	30	30		30	30
التسامي	174.	252.	0.377	0.290	0.466	0.366	0.066	1	0.723
	0.307	0.179	0.040	0.113	0.009	0.047	0.001	30	0.000
	30	30	30	30	30	30	30		30
معنى الحياة ككل	-0.022	0.463	0.463	0.161	0.788	0.780	0.703	0.723	1
	0.906	0.10	0.10	0.390	0.000	0.000	0.000	0.000	30
	30	30	30	30	30	30	30	30	

يتبين من الجدول السابق انه لا توجد علاقة ارتباطيه ذات دلالة إحصائية عند مستوى ٠.٠٥ بين المجموع الكلى للمقياسين . بمعنى إن الدرجة الكلية على المقياس الأول الصفاء الروحي لا ترتبط بالدرجة الكلية على المقياس الثاني معنى الحياة بطريقه يمكن الاعتماد عليها إحصائيا، ولكن نلاحظ انب بعد الثقة في (الصفاء الروحي) ارتبط ارتباط دال موجب ببعد بالرضا و بعد التسامي ومعنى الحيا ككل عندي مستوى دلالة ٠.٠٥٠٥ . مما يوضح انب الثقة تمنح المريضة مواجهه تحديات المرض والخروج منه بقوة اكبر وشعور اعمق بالمعنى.

كما اتفقت بشكل جزئي مع دراسة (سيما اوستونداغ وآخرون، ٢٠٢٤) والتي قامت على فكره المقارنة بين مرضا السرطان والأصحاء في دراستا (ومقدمي الرعاية في دراسة اوستونداغ) والتي توصلت في نتائجها بوجود علاقة ارتباطيه إيجابية ومعتدلة بين احتياجات المرضى واحتياجات مقدمي الرعاية .

وتتفق تلك النتيجة مع ما توصلت اليه دراسة (كيونغ وشين، ٢٠٢٠) بان الرعاية الروحية يجب ألا تقتصر على الجانب الديني، بل يجب ان تلبي الاحتياجات الوجودية الداخلية للمرضى مثل التعاطف وتشجيع الأمل وإيجاد المعنى في ظروفهم. كما اتفقت مع المراجعة الشاملة التي قامت بها دراسة (مبشر قند وسخجيت كورو، ٢٠٢٤)

للأدبيات بان الروحانية والتدين والتفاؤل هي عوامل حيوية في تحسين جودة حياة مرضى السرطان وتسهيل رحلة علاجهم.. كما ان هذه المفاهيم تساهم في التخفيف من تلك المشكلات النفسية التي يواجهها المرضى كالاكتئاب والقلق.

جدول (١٢)

معاملات الارتباط بين درجات أفراد عينة الدراسة على أبعاد الصفاء الروحي وأبعاد

معنى الحياة للأصحاء (ن=٣٠)

الأبعاد	القبول	الملاذ	الثقة	الصفاء ككل	الهدف	الرضا	المسئولية	التسامي	الحيا ككل
القبول	1	.٧٥٨	.٥٩١	.٩٥٤	244.-	-.٠٦٨	.٣٢٥	.٢٣٠	.٠٩٢
	30	.٠٠	.٠٠١	.٠٠٠	.١٩٣	.٧٣٨	.٠٨٠	.٢٢١	.٦٣٠
		٣٠	٣٠	٣٠	٣٠	٣٠	٣٠	٣٠	٣٠
الملاذ	.٧٥٨	١	.٣٩٣	.٨٩٥	.٢٠٨	.٠٨٩	.٢٤٩	.٢٠٢	.٠٥٩
	.٠٠٠	٣٠	.٠٣١	.٠٠٠	.٢٧١	.٧٥٧	.١٨٥	.٢٨٥	.٦٣٠
	٣٠	٣٠	٣٠	٣٠	٣٠	٣٠	٣٠	٣٠	٣٠
الثقة	.٥٩١	.٣٩٣	١	.٦٧٨	-.٠٦٩	.٠٥٩	.٢٠٢	.٢٠٨	.١٣٣
	.٠٠١	.٠٣١	٣٠	.٠٠٠	.٧١٩	.٧٥٧	.٢٨٤	.٠٦٧	.٤٨٢
	٣٠	٣٠	٣٠	٣٠	٣٠	٣٠	٣٠	٣٠	٣٠
الصفاء الروحي ككل	.٩٤٥	.٨٩٥	.٦٧٨	١	-.٢٢٤	-.٠٥٧	.٣١١	.٢٤٦	.١٠٠
	.٠٠٠	.٠٠٠	.٠٠٠	٣٠	.٢٣٤	.٧٦٥	.٠٩٥	.١٩١	.٦٠١
	٣٠	٣٠	٣٠	٣٠	٣٠	٣٠	٣٠	٣٠	٣٠
الهدف	244.-	208.-	-.٠٦٩	224.-	١	.٤٦٦	.٤٨٦	.٢٣٩	.٧٥٤
	.١٩٣	.٢٧١	.٧١٩	.٢٣٤	٣٠	.٠٠٩	.٠٠٧	.٠٦٧	.٠٠٠
	٣٠	٣٠	٣٠	٣٠	٣٠	٣٠	٣٠	٣٠	٣٠
الرضا	-.٠٦٤	-.٠٨٩	.٠٥٩	-.٠٥٧	.٤٦٦	١	.٣٦٧	.٢٩١	.٦٧٦
	.٧٣٨	.٦٤١	.٧٥٧	.٧٦٥	.٠٠٩	٣٠	.٠٤٦	.١١٨	.٠٠٠
	٣٠	٣٠	٣٠	٣٠	٣٠	٣٠	٣٠	٣٠	٣٠
المسئولية	.٣٢٥	.٢٤٩	.٢٠٢	.٣١١	.٤٨٦	.٣٦٧	١	.٦٩٢	.٨٥٤
	.٠٨٠	.١٨٥	.٠٠٧	.٠٩٥	.٠٠٧	.٠٤٦	٣٠	.٠٠٠	.٠٠٠
	٣٠	٣٠	٣٠	٣٠	٣٠	٣٠	٣٠	٣٠	٣٠
التسامي	.٢٣٠	.٢٠٢	.٢٣٩	.٢٤٩	.٣٣٩	.٢٩١	.٦٩٢	١	.٧٦٠
	.٢٢١	.٠٨٠	.٠٦٧	.١٩١	.٠٦٧	.١١٨	.٠٠٠	٣٠	.٠٠٠
	٣٠	٣٠	٣٠	٣٠	٣٠	٣٠	٣٠	٣٠	٣٠
معنى الحياة ككل	-.٠٩٢	.٠٥٧	.١٣٣	.١٠٠	.٧٥٤	.٦٧٦	.٨٥٤	.٧٦٠	١
	.٦٣٠	.٧٥٦	.٤٨٢	.٦٠١	.٠٠٠	.٠٠٠	.٠٠٠	.٠٠٠	٣٠
	٣٠	٣٠	٣٠	٣٠	٣٠	٣٠	٣٠	٣٠	٣٠

..الجدول يوضح عدم وجود إلى علاقه ارتباطيه داله عند مستوى دلالة ٠.٠٥ سواء بين بعاد لصفاء الروحي بأبعاد معنى الحياه ، أو بين لمجموع الكل لهما لدى النساء الأصحاء . فاختلقت تلك النتيجة مع دراسة (روسلا وآخرون، ٢٠٢٢) التي توصلت إلى وجود ارتباطات إيجابيه بين معنى الحياه وتقبل السرطان .
تم تطبيق اختبار فيشر للبيانات للمقارنات بين معاملات ارتباط بعاد متغيرات الدراسة كما موضح بالجدول التالي

جدول (١٣)

نتائج اختبار فيشر للمقارنة بين معاملات الارتباط للمجموعتين المريضات (ن=٣٠)

والأصحاء (ن=٣٠)

الأبعاد	ار١	ار٢	تحويل ار إلى z	الخطأ المعياري للفرق	قيمة Z المحسوبة	القيمة الحرجة ل z	الدلالة
القبول-الملاذ	.688	.758	.844 1.016	0.272	0.632	1.96	غير دال
القبول-الثقة	368	.591	.380 .272	0.272	1.099	1.96	غير دال
الملاذ-الثقة	.439	.393	.471 .416	0.272	0.202	1.96	غير دال
الهدف-الرضا	.555	.466	.625 .505	0.272	0.441	1.96	غير دال
الهدف -المسئولية	.330	.486	.342 .530	0.272	0.691	1.96	غير دال
الهدف التسامي	.644	.399	.765 .422	0.272	1.261	1.96	غير دال
الرضا -المسئولية	.411	.367	.437 .300	0.272	.504	1.96	غير دال
الرضا -التسامي	.366	.291	.383 .852	0.272	1.724	1.96	غير دال
المسئولية-التسامي	.566	.692	.641 .852	0.272	0.776	1.96	غير دال
القبول-الهدف	-.113	-.244	.113 .249	0.272	0.5	1.96	غير دال

القبول-الرضا	-. 022	-. 068	. 022	0. 272	0. 169	1. 96	غير دال
			. 068				
القبول-المسئولية	. 189	. 325	. 191	0. 272	0. 537	1. 96	غير دال
			. 337				
القبول-التسامي	. 174	. 230	. 175	0. 272	0. 217	1. 96	غير دال
			. 234				
الملاذ-الهدف	. 042	. 208	. 042	0. 272	0. 621	1. 96	غير دال
			. 211				
الملاذ-الرضا	. 068	. 086	. 068	0. 272	0. 066	1. 96	غير دال
			. 086				
الملاذ-المسئولية	. 145	. 249	. 146	0. 272	0. 397	1. 96	غير دال
			. 254				
الملاذ-التسامي	. 252	. 202	. 257	0. 272	0. 195	1. 96	غير دال
			. 204				
الثقة-الهدف	-. 282	-. 069	. 29	0. 272	0. 812	1. 96	غير دال
			. 069				
الثقة-الرضا	-. 488	. 059	. 533	0. 272	2. 176	1. 96	دال
			. 059				
الثقة-المسئولية	. 290	. 202	. 298	0. 272	0. 346	1. 96	غير دال
			. 204				
الثقة-التسامي	-. 377	. 208	. 397	0. 272	2. 235	1. 96	دال
			. 211				

من خلال التحليلات التالية قمنا بها ، وجد ان معظم الفروق بين معاملي الارتباط كانت غير داله إحصائيا عند مستوى دلالة ٠.٠٠٥، اختلفت تلك النتيجة مع دراسة (روسلا وآخرون، ٢٠٢٢) التي توصلت إلى وجود ارتباطات إيجابية بين معنى الحياه وتقبل السرطان . وهذا يعنى ان قوة العلاقة بين المتغيرات في المجموعتين (المريضات والأصحاء) كانت متشابهة بشكل كبير، وان الاختلافات التي ظهرت في الأرقام اختلافات عشوائية لا يمكن الاعتماد عليها في استنتاج وجود فرق حقيقي ومهم . باستثناء الحالتين التاليتين التي اظهرها فروق داله إحصائيا . وهما الحالة الأولى : (الثقة - الرضا) فكانت معاملات ارتباطهم (٤٨٨،) و (٠.٥٩) ، حيث كانت قيمه المحسوبة هي ٢.١٧٦- . فهي اكبر من القيمة الحرجة (١.٩٦)

حيث كان الفرق دال إحصائياً بين هذين العاملين لصالح المريضات عند مستوى دلالة ٠.٠٥.

الحالة الثانية: (الثقة - التسامي) معاملات ارتباطهم (٧٣٣-،) و (٢٠٨) . حيث كانت قيمه المحسوبة هي ٢.٢٣٥ - . فهي اكبر من القيمة الحرجة (١.٩٦) كما كان الفرق دال إحصائياً بين هذين العاملين لصالح المريضات عند مستوى دلالة ٠.٠٥.

ومناقشتنا لنتيجة الفرضية هتقسم إلى قسمين القسم الأول نوضح فيه سبب عدم وجود فروق بين المريضات والأصحاء في الصفاء الروحي ومعنى الحياة ، ولعل اصدق تفسير نستطيع تقديمه هو دعمنا لوجهه نظر فرانكل ، ففي ضوء نظريه فرانكل بان الوقت الذى تشعر به المريضات (بالتحسن) ،يساعدهم على إعادة اكتشاف المعنى من خلال المعاناة، عبر تمكينهن من تبني موقف إيجابي وتحويل الألم إلى فرصه للنمو، فاخفاء الفروق الإحصائية بين المريضات والأصحاء ، سببه سد(الفراغ الوجودي) وتنمية إحساسهم بالهدف والرضا ، مما يؤكد فعالية العلاج القائم على المعنى وفقاً لمبادئ فرانكل فرانكل. (اديلر، ٢٠٠٥)

أما القسم الثاني ففي نركز على الفروقات التي وجدت بين الأبعاد ،ولقد عثر الباحثان على بعض التفسيرات لتلك النتائج في محاوله منهم معرفه من اين تأتى الثقة كجزء من عمليه الصفاء الروحي التي تتفوق فيها المريضات على الأصحاء.

بل كيف تناغمت مع التسامي والرضا كجزء من مكونات معنى الحياة . فذه با إلى "مارجريتاً" حين قالت ان الظواهر التي حدثت قبل الصفاء الروحي والتي تخذ لف من شخص لآخر ..كما ان هناك موقف يريد الفرد فيه ان يتحرر أثناء حدوث له تجربه أو ازمه موجهه ، وعندما يتحرر يمكن للمرء ان يشعر بالصفاء الروحي

(Pejner, 2015).,p4)

ونضيف إلى ذلك بعد الرجوع إلى الأطر المرجعية السابقة في نفس نقطه الفرض نلاحظ على سبيل المثال دراسة(مارى وآخرين ٢٠٠٩) التي كانت تقيس الصفاء بين المرضى (سكر وسرطان) والأصحاء ، باستخدام مقياس (سلام داخلي

توافق مع المحيط والارتباط بمعنى أعلى) فبالرغم من وجود فروق داله لصالح الأصحاء باستثناء البعد الروحي كانت لصالح المرضى، ألا ان الدراسة ذكرت ان هناك ((تقارب)) بين المجموعتين ، مفسره ذلك بان المرض يحفز معنى الحياه لديهم ، أما الأصحاء فانشغالهم قد يقلل من تركيزهم على الأسئلة الوجودية.(Mary,Et al,2009)

خاصا ان الناحية النفسية التي يبدأ فيه المريض الانسحاب داخل نفسه ، مع اتساع مساحة أحزانه الداخلية وعلى مستوى الظاهر تقل دموعة ويبذل محاولات لكي يبدو متقبلا.. بل قويا على غير حقيقته، لان خلاف ذلك يمس روحانيته وقوة أيمانه أمام الآخرين، فيظهر ثقة في رحمة الله وقدرته على إنجاح العلاج، وان كان هو في الواقع منهارا أمام واقعه، مشغولا بما تحمله له الأيام، مثقل بنفسه التي تموج بتساؤلات لا إجابة لها مع الخوف.. والرجاء في الانقاذ. مروراً بالصراخ والتضرع على ان يخلهم الله من هذه المحنة إلى ان صاروا في دائرة الله ونوره.(زخارى،٢٠٠٤،ص٧-١٢)

فالنتائج الدالة إحصائيا تظهر ان العلاقة بين بعد الثقة (من الصفاء الروحي) و بعد الرضا وبعد التسامي (من معنى الحياه) ليشت متماثلة بين المرضى والأصحاء ، هذا يعنى ان الحالة الصحية تؤثر بشكل حقيقي على كيفية الارتباط هذه الأبعاد النفسية والروحية ببعضها البعض. وتلك النتائج تتفق مع دراسة(كيونغ وشين،٢٠٢٠) بان الرعاية الروحية ترتبط ب أتاحه الفرصة للتأمل الداخلي، مساعدة المريض على إيجاد المعنى . باختصار الفروق التي لاحظناها في الارتباطات تعكس تأثير (المرض) على العلاقة بين الثقة والرضا ، وبين الثقة، والتسامي .

نتائج ومناقشة الفرض الثاني

(٢) توجد فروق داله إحصائيا بين مريضات سرطان الثدي والأصحاء في أبعاد الصفء الروحى.

جدول (١٤)

نتائج تحليل التباين المتعدد لدلاله الفروق في متوسطات استجابات المريضات

والأصحاء حول الصفء الروحى

قيمہ (ف)	درجہ الحرىة	قيمہ الدلالة	حجم التأثير
1.731	f(3,56)	.175	.084

يتضح من جدول (١٤) ان نتائج تحليل التباين المتعدد لتقييم الفروق في أبعاد الصفء الروحى بين مجموعتي المريضات والأصحاء يؤكد على عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين المجموعتين عند مستوى دلالة ٠.٠٠٥. في الصفء الروحى بشكل عام ، ألا ان حجم التأثير كان كبير في الفرق بين المجموعتين (٠.٠٨٤) مما يوحى بأن التأثير العملي للمجموعات على الأبعاد ليس قويا في الاختبار الشامل.

فتلك النتيجة مهمة جدا وإيجابية لدراستنا ، فهي تؤكد لنا ان مجموعتي المريضات والأصحاء كانتا متكافئتين ومتشابهين بشكل كبير في مستوى الصفء الروحى في نقطه القياس ، فليس هناك فروق كانت موجودة أصلا بين العينيتين بمعنى لم تكن هناك مشكلة أولية في الصفء الروحى تميز المريضات عن الأصحاء. وتختلف مع نتائج دراسة (سيما اوستونداغ وآخرون ، ٢٠٢٤) التي ترى ان مرضى السرطان بحاجة إلى رعاية روحية اكثر .

كما تتشابه نتائج الدراسة الحالية بشكل لافت للنظر مع ما توصلت اليه مارى واخرين (٢٠٠٩) في قياسها لمفهوم الصفء لدى مرضى السكر والسرطان والأصحاء باستخدام مقياس متعدد الأبعاد يشمل السلام الداخلى والتوافق مع المحيط والارتباط بمعنى اعلى، فعلى غرار نتائجنا، مثل البعد الروحى استثناء كان فيه التفوق لصالح مجموعة المرضى، وهو ما ينسجم مع بياناتنا، والا هم ان الدراستين تتقاطعان في الإشارة إلى وجود تقارب نسبي في المستوى العام للصفء الروحى بين المجموعتين هذا

التشابه يغني المناقشة التحليلية ، حيث يمكن تفسير التقارب بناء على فرضية ان المرض يحفز المعنى الوجودي للحياة لدى المصابين ، بينما يؤدي لانشغال اليومي للأصحاء إلى تقليل تركيزهم على التساؤلات الجوهرية ، الأمر الذي يقلل من حده الفارق المتوقع في مستوى الصفاء الكلي.(Kreitzer et al., 2009)

وقد ترجع تلك النتيجة إلى الناحية النفسية التي يبدأ فيه المريض الانسحاب داخل نفسة ، مع اتساع مساحة أحزانه الداخلية وعلى مستوى الظاهر تقل دموعه ويبدل محاولات لكي يبدو متقبلاً.. بل قويا على غير حقيقته، لان خلاف ذلك يمس روحانيته وقوة إيمانه أمام الآخرين، فيظهر ثقة في رحمة الله وقدرته على إنجاح العلاج، وان كان هو في الواقع منهارا أمام واقعه، مشغولا بما تحمله له الأيام، مثقل بنفسة التي تموج بتساؤلات لا إجابة لها مع الخوف.. والرجاء في الانقاذ. مروراً بالصراخ والتضرع على ان يخلهم الله من هذه المحنة إلى ان صاروا في دائرة الله ونوره.(زخاري، ٢٠٠٤، ص٧-١٢)

الحى أنا يصل إلى حاله السلام الداخلي والهدوء التي تنشأ عن الوعي الواضح بالذات والعالم، فالصفاء هنا حاله من القبول والرضا عن الذات والآخرين والحياء بشكل عام ويمكن تحقيقه من خلال التأمل واليقظة والرحمة والحب.

(Sims, Nelson, & Puopolo, 2014,p107)

وتلك النتائج تؤكد أيضا ما ذكره (روبرتس واسبرى في مقالهم ١٩٩٣) أثناء عرضهم لتحليل مفهوم الصفاء الروحي، بأن تعريفات الصفاء الروحي الموجودة كانت غامضة ومتضاربة ، فهذا يشير إلى صعوبة تحديد المفهوم نفسة بشكل واضح ، وهو ما يجعل قياسه تحديا . (Roberts &Aspy,1993,p145:147)

وتغزو تلك الصعوبة إلى التحولات التي يمر بها مريض السرطان الذى قدمها (موريس خليفه في عام ٢٠٠٤) بكتاب تحت عنوان " تحولات،، تأملات في الحالة النفسية والروحية لمريض السرطان" ، فوصف مرض السرطان في هذا الكتاب " مرض الفردوس" مشيرا إلى التحولات الثلاثة الذى يمروا بها المرضة في تلك التجربة من وجهه نظره ، حيث قسمها إلى التحول الأول: (أحاطت بي ظلمة) فهو تحول نفسي

فيه التغيرات العاطفية والذهنية التي يمر بها المريض من يأس وصدمة، الخ ، والتحول الثاني (اخرج من الحبس نفسي) وهو التحول الروحي وبه يعرض التطور في الجانب الايماني والروحاني خلال الرحلة بالتكليف والقبول ، والتحول الثالث (فكان نور)وهو السلام الروحي أو التجربة التحويلية.

وأخيرا فيكون الأمل في هذه المرحلة على المستوى النفسي في نجاح فاعلية العلاج في القضاء على المرض مهما طال الزمن ، وعلى المستوى الروحي في قبول واستجابة الدعاء والصلاة فتحدث المعزة ويتم الشفاء.(مرجع سابق، ٢٠٠٤، ص ١٤-٧)

نتائج و مناقشه الفرض الثالث

٣) توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين أبعاد معنى الحياه بين مريضات سرطان الثدي والأصحاء، وجاءت النتائج كما موضح بالجدول (١٥)

جدول (١٥)

نتائج تحليل التباين المتعدد لدلالة الفروق في متوسطات استجابات المريضات

والأصحاء حول معنى الحياه

قيمه (ف)	درجه الحرة	قيمه دلالة	حجم التأثير
2.463	f(4,55)	٠.٠٥٦	٠.١٥٢

يتضح من الجدول (١٥) ان نتائج تحليل التباين المتعدد لتقييم الفروق في أبعاد معنى الحياه بين مجموعتي المريضات والأصحاء بعدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين المجموعتين عند مستوى دلالة ٠.٠٠٥ . في معنى الحياه بشكل عام ، ألا ان حجم التأثير كان كبير في الفرق بين المجموعتين (٠.١٥٢) مما يوحي بأن التأثير العملي للمجموعات على الأبعاد كان قويا على الرغم من عدم بلوغه مستوى الدلالة الإحصائية في الاختبار الشامل.

ويغزو ذلك لحجم التأثير الكبير ،ففي تحليل ما بعد الفحص ، والذي أوجد فروق داله في العديد الهدف والرضا ، يغزو لنظريه فرانكل الذي تؤكد على فكره ان الإنسان يظل قادر على اختيار موقفه رغم التحديات، حيث تؤكد النتائج صحة النظرية في فقدان جزئي للمعنى. (اديلر ، ٢٠٠٥)

وأيضاً لوجهه نظر (عبدالله عسكر، ١٩٨٨، ١٧٧) في بحثه في عالم المريض عن بقايا المعنى وتدعيمه للوصول بالذات إلى الارتقاء والاندماج في العالم بحثاً عن الوجود من خلال التواصل بين الأنا والآخر. (عبد النعيم، ٢٠٢٠، ص٥٣) ولتقديم تفسير أكثر تفصيلاً ، تم فحص نتائج اختبارات أحاديه المتغير لكل بعد على حدة كما هو موضح بالجدول (١٦) التالي

جدول (١٦)

نتائج تحليل التباين الأحادي لدلالة الفروق في متوسطات استجابات المريضات والأصحاء حول معنى الحياة

معنى الحياة	مصدر التباين	مجموع المربعات	درجة الحرية	متوسط المربعات	قيمة (ف)	مستوى الدلالة	حجم التأثير
الهدف	بين المجموعات	١٢٠٠.٤١٧	١	١٢٠٠.٤١٧	٨.٦١٦	٠.٠٠٥	٠.١٢٩
	داخل المجموعات	٨١٠.٥٦٧	٥٨	١٣.٩٧٥			
	المجموع	٩٣٠.٩٨٣	٥٩				
الرضا	بين المجموعات	٥٢.٢٦٧	١	٥٢.٢٦٧	٤.٥٤٤	٠.٠٣٧	٠.٠٧٣
	داخل المجموعات	٦٦٧.٠٦٧	٥٨	١١.٥٠١			
	المجموع	٧١٩.٣٣٣	٥٩				
المسئولية	بين المجموعات	١٠٠.٨٧	١	١٠٠.٨٧	٠.٠٧٣	٠.٧٨٨	٠.٠٠١
	داخل المجموعات	٨٤٧.٢٦٧	٥٨	١٤.٦٠٨			
	المجموع	٨٤٨.٣٣٣	٥٩				
التسامي	بين المجموعات	٤.٨١٧	١	٤.٨١٧	٠.٦٥٠	٠.٤٢٤	٠.٠١١
	داخل المجموعات	٤٣٠.٠٣٣	٥٨	٧.٤١٤			
	المجموع	٤٣٤.٨٥٠	٥٩				

فبيّن الجدول السابق فحص للاختبارات أحاديه المتغير لكل بعد على حدة تبين وجود فروق داله إحصائيا عند مستوى دلالة ٠.٠٠٥. في بعدى الهدف مصحوب بحجم تأثير كبير (٠.١٢٩) والرضا مصحوب بحجم تأثير متوسط (٠.٠٧٣) ، كما تبين من الجدول ان متوسط الأصحاء اعلى من متوسط المريضات ، بينما لم يتم العثور على فروق داله في بعدى المسئولية والتسامي. فتدعم أيضا تلك النتيجة نظريه فرانكل حيث بان المعنى يبنى عبر إعادة توجيه التركيز نحو الأهداف الذى

كان حجم تأثيره كبير والرضا بتأثيره المتوسط أيضا، فتدعم هذه البيانات بشكل قوى الطرح فرانكللي بان المعنى لا يعطى بل يكتشف ويخلق ، وان الإرادة الواعية لتغيير الموقف وتحديد الأهداف هي أدوات محورية للتغلب على الفراغ الوجودي وتحقيق الرضا بالرغم من المعاناة . (مرجع سابق ،٢٠٠٥)

فالفروق في بعدى الهدف لصالح الأصحاء والرضا لصالح المريضات ساهمت بشكل رئيسي في حجم التأثير الكبير الذى أرصدته النتائج في البعد الكلى ، وهذا يعنى ان تجربه المريضات مع السرطان قد أثرت بشكل مباشر على شعورهن بوجود هدف في الحياه بشكل اقل من الأصحاء ومدى رضاهن عنها بشكل إيجابي اكثر من الأصحاء ، مما احدث اختلافا كبيرا بينهما وبين الأصحاء. كما ان عدم وجود فروق في بعدى التسامي والمسؤولية يشير إلى ان هذه الجوانب من شخصيتهم قد تكون اكثر استقرار ، ولم تتأثر بنفس القدر بتجربة المرض.

ومن العرض السابق للنتائج يتضح ان الدراسة الحالية قدمت صورة اكثر دقة ، اذا لم تجد فروقا داله في معنى الحياه العام بين المجموعتين في الأبعاد الأربعة مجتمعه، رغم وجود حجم تأثير كبير، كما وجدت فروق في بعد الهدف لصالح الأصحاء ممكن يؤكد وجهه نظر فرانكل ، بأن المعاناة يمكن ان تؤثر على شعور الفرد بالهدف ،والرضا لصالح المريضات ، مما يتفق مع الاتجاه العام للدراسات السابقة بتأثير المرض على معنى وجودة حياه المرض كدراسة (كيونغ وشين،٢٠٢٠) ،(روسيلا ماتيا واخرون،٢٠٢٢) ، ،دراسة (مبشر قند وسخجيت كورو،٢٠٢٤).

فنتحتم المناقشة قائلين تتوافق نتائج الدراسة الحالية مع نظرية فرانكل في علم النفس الوجودي حيث ان الأبعاد التي انخفضت فيها متوسطات عينه المريضات عن الأصحاء كالهدف والدرجة الكلية في الدراسة الحالية تعكس ازمه معنى جزئيه ناتجة عن المرض، وهذا ما يتوقعه فرانكل في ظل المعاناة، في الوقت نفسه حافظن المريضات على درجة مرتفعة في بعد (الرضا) ممكن يؤكد فكره ان الإنسان يظل قادر على اختيار موقفه رغم التحديات ، حيث تؤكد النتائج صحة النظرية في فقدان جزئي للمعنى. (مرجع سابق ،٢٠٠٥)

المراجع العربية

- أديلر، أ. (٢٠٠٥). معنى الحياة (ع.ن، بشرى، مترجم)، المجلس الأعلى للثقافة. الهيئة المصرية العامة للكتاب.
- زخاى، م. خ (٢٠٠٤) تحولات .. تأملات نفى حاله النفسية والروحية لمرضى السرطان: (رؤية مسيحية). ط١.
- سمات، ج. (٢٠١٧): الكتاب الصغير للصفاء: دليل سريع للتركيز وتخليص عقلك من الفوضى، مكتبة جرير.
- عبد الحليم، أ.م. (٢٠١٠). قلق المستقبل وعلاقته بمعنى الحياة والضغط النفسية لدى عينة من الشباب (ورقة مؤتملة) . المؤتمر السنوي الخامس عشر - الإرشاد الأسرى وتنمية المجتمع نحو أفاق إرشادية رحبة (ص ٢٩٣-٣٦٨) لمركز الإرشاد النفسي، جامعة عين شمس .
- عبد النعيم، أ.م. (٢٠٢٠): قلق الموت من السرطان، المكتب العربي للمعارف، ط١، القاهرة.
- محمد، ك.أ. (٢٠٢١). الطاقة الروحية لحكماء الفراعنة وأطلانتس. دار كنوز للنشر والتوزيع.
- محمد، س.ع. فعاليه التحليل بالمعنى في علاج خواء المعنى وفقدان الهدف في الحياة لدى عينة من طلاب جامعة الإمارات العربية المتحدة. ورقة مؤتمر). المؤتمر السنوي الثالث عشر لمركز الإرشاد النفسي، من أجل التربية المستدامة. (ص ١١١-١٥١) جامع الإمارات المتحدة. مركز الإرشاد النفسي-جامعة عين شمس

المراجع الأجنبية

- Boyd-Wilson, B. M., McClure, J., & Walkey, F. H. (2004). Serenity: Much more than just feeling calm. In *Advances in Psychology Research* (Vol. 30). Nova Science Publishers.

- **Brown, A. J., Sun, C. C., Urbauer, D., Zhukovsky, D. S., Levenback, C., Frumovitz, M., Thaker, P. H., Bodurka, D. C., & Ramondetta, L. M.** (2015). Targeting those with decreased meaning and peace: A supportive care opportunity. *Supportive Care in Cancer*, 23(7), 2007–2012. <https://doi.org/10.1007/s00520-015-2630-1>
- **Chan, A. C.-K., Steger, M. F., Chui, R. C.-F., Siu, N. Y.-F., Ip, S. C. P. W., & Lam, B. Y.-H. (Eds.).** (2023). *Proceedings of the Meaning in Life International Conference 2022 - Cultivating, promoting, and enhancing meaning in life across cultures and life span (MIL 2022)*. Springer Nature.
- **Gull, M., & Kaur, S.** (2024). Religiosity, spirituality, and quality of life in cancer patients: a literature review. *Revista Bioética*, 32. <https://doi.org/10.1590/1983-803420243521EN>
- **Jimenez-Fonseca, P., Lorenzo-Seva, U., Ferrando, P. J., Carmona-Bayonas, A., Beato, C., García, T., Muñoz, M. d. M., Ramchandani, A., Ghanem, I., Rodríguez-Capote, A., Jara, C., & Calderon, C.** (2018). The mediating role of spirituality (meaning, peace, faith) between psychological distress and mental adjustment in cancer patients. *Supportive Care in Cancer*, 26(5), 1411–1418. <https://doi.org/10.1007/s00520-017-3969-0>
- **Kang, K.-A., & Kim, S.-J.** (2020). Comparison of perceptions of spiritual care among patients with life-threatening cancer, primary family caregivers, and hospice/palliative care nurses in South Korea. *Journal of Hospice & Palliative Nursing*, 22(6), 532–551. <https://doi.org/10.1097/NJH.000000000000069>
- **Khosravani, M., & Nejat, N.** (2022). Spiritual experiences of patients in the cancer trajectory: A content analysis. *Ethiopian Journal of Health Sciences*, 32(6), 1147–1156.
- **Kreitzer, M. J., Gross, C. R., Waleekhachonloet, O., Reilly-Spong, M., & Byrd, M.** (2009). The Brief Serenity Scale: A psychometric analysis of a measure of spirituality and well-being. *Journal of Holistic Nursing*, 27(1), 7–16.
- **Palmer, C.** (2021). *Finding meaning and success: Living a fulfilled and productive life*. Rowman & Littlefield Publishers.
- **Pejner, M. N.** (2015). Serenity—Uses in the care of chronically ill older patients: A concept clarification. *Open Journal of Nursing*, 5(1), 1–9.
- **Quinto, R. M., De Vincenzo, F., Campitiello, L., Innamorati, M., Secinti, E., & Iani, L.** (2022). Meaning in life and the acceptance of cancer: A systematic review. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(9), 5547. <https://doi.org/10.3390/ijerph19095547>

- **Roberts, K. T., & Aspy, C. B.** (1993). Development of the clarity scale: A model and test of internal consistency. *Journal of Nursing Measurement*, 1(2), 123-134.
- **Rusdi, A., Rachmawati, M. A., Yang, L., Wangnan, P., & Andriansyah, Y.** (2022). Models of helping, happiness, and spiritual serenity among Indonesian and Chinese students. *International Journal of Innovative Research and Scientific Studies*, 5(2), 83–89.
- **Sims, G. K., Nelson, L. L., & Puopolo, M. R. (Eds.).** (2014). *Personal peacefulness: Psychological perspectives*. Springer.
- **Üstündağ, S., Çekiç, Y., Kurtoglu, Y., & Ünver, G.** (2024). A comparative analysis of spiritual care needs among cancer patients receiving home care and their caregivers in Turkey. *Journal of Religion and Health*, 63, 1490–1503. <https://doi.org/10.1007/s10943-024-01997-2>
- **Velosa, T.** (2023). Spiritual Distress and Depression in Palliative Care. In *Palliative Care - Current Practice and Future Perspectives*. IntechOpen. <https://doi.org/10.5772/intechopen.109151>
- **Whitford, H. S., & Olver, I. N.** (2012). The multidimensionality of spiritual wellbeing: peace, meaning, and faith and their association with quality of life and coping in oncology. *Psycho-Oncology*, 21(9), 920–928. <https://doi.org/10.1002/pon.2017>

Abstract:-

The study aimed to **compare and detect the nature of the correlational relationship** between the two variables: **Spiritual Well-being and Meaning in Life**, and to **compare the strength and direction of this relationship** between the two study groups (patients and healthy women). It also aimed to **determine the differences** between the two groups in **Spiritual Well-being and its sub-dimensions**, and the differences between the two groups in **Meaning in Life and its sub-dimensions**. The **sample** included **(30) female breast cancer patients and (30) healthy women**. The study used the **Spiritual Well-being Scale** (Roberts and Espy, 1993), translated by the researchers, and the **Meaning in Life Scale** (Rabiha Mohamed Mahmoud Helal, 2023). The **statistical methods** used in the current study were: **Cronbach's Alpha coefficient, t-test, Mean and Standard Deviation, Multivariate Analysis of Variance (MANOVA)** and its **effect size, Pearson correlation coefficient, and Fisher's Z test** (manual) for comparing correlation coefficients.

The **results:-** were as follows: First, **no statistically significant differences** were found between the two groups on the **seven dimensions combined** at a significance level of ($\alpha=0.05$), with a **large effect size** ($\eta^2=0.210$).

Second, regarding the **patients**, there were generally **no statistically significant correlations** between Spiritual Well-being and Meaning in Life at a significance level of (0.05), **except** for the **Confidence** sub-dimension of Spiritual Well-being, which was **positively and significantly correlated** with **Satisfaction, Transcendence**, and the **total score of Meaning in Life** at a significance level of (0.05).

For the **healthy individuals**, there were **no statistically significant correlations** either between Spiritual Well-being and Meaning in Life generally, or even between the dimensions, at a significance level of (0.05).

The study also showed **no statistically significant differences** between the two groups of patients and healthy individuals across the **three combined dimensions of Spiritual Well-being** at a significance level of (0.05), meaning that the three dimensions as a whole **do not differ significantly** between the two groups. The **effect size** was also **very small** (0.084).

The final results showed **no statistically significant differences** between the two groups of patients and healthy individuals across the **four combined dimensions of Meaning in Life** at a significance level of (0.05), meaning that the four dimensions as a whole **do not differ significantly** between the two groups. However, the analysis revealed a **large effect size** (0.152).

Univariate tests for each dimension revealed the presence of **statistically significant differences** in the **Goal dimension in favor of the healthy individuals** and the **Satisfaction dimension in favor of the patients** at a significance level of (0.05). These differences were accompanied by a **large effect size** in the Goal dimension (0.129) and a **medium effect size** in the Satisfaction dimension (0.037).

These results suggest that **health status affects an individual's ability to find goal and satisfaction in their life**.

The results also showed **no significant differences** between the patients and healthy individuals in the **Transcendence and Responsibility** dimensions at a significance level of (0.05).